EJEMPLO FICTICIO

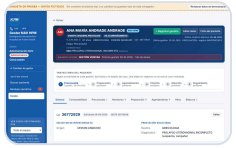
¿Cómo se realiza una gestión?

PACIENTE	ESPECIALIDAD
Ana María Andrade (ficticia)	**Ginecología**
ESTADO	TIPO DE LLAMADO
VIGENTE_REQUIERE_PRESTACION	**Seguimiento**



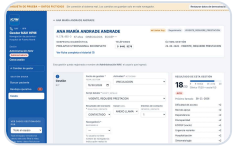
1. Aparece en la bandeja
Marcada para llamar hoy.

↓



2. Se revisa el caso
Cabecera, trayectoria y última gestión.

↓



3. Se registra la llamada
VINCULACION · «VIGENTE, REQUIERE PRESTACION» · CONTACTADO.

↓

4. Siguiente paso
El sistema calcula el próximo llamado (1, 3 o 6 meses) y lo muestra en el caso.

Conceptos para empezar

Vigente. La solicitud sigue activa y el paciente aún necesita la atención. No significa que tenga hora.

Seguimiento. Ya hubo contacto efectivo; toca volver a llamar según su frecuencia.

Llamar hoy. La bandeja lo marca en rojo: corresponde llamar hoy.

Contacto efectivo. Resultado CONTACTADO con su fecha; sin él no se programa el próximo llamado.

PARA TENER PRESENTE

Antes de comenzar

- Revisar los antecedentes disponibles antes de realizar una gestión.
- Registrar correctamente el resultado de las acciones realizadas.
- Mantener actualizada la información que corresponda.
- Consultar el historial cuando sea necesario.
- Respetar las funciones y los permisos de cada módulo.
- Consultar la ayuda cuando una opción no esté clara.

El objetivo es trabajar de manera ordenada, mantener la trazabilidad de las gestiones y facilitar la continuidad del seguimiento.

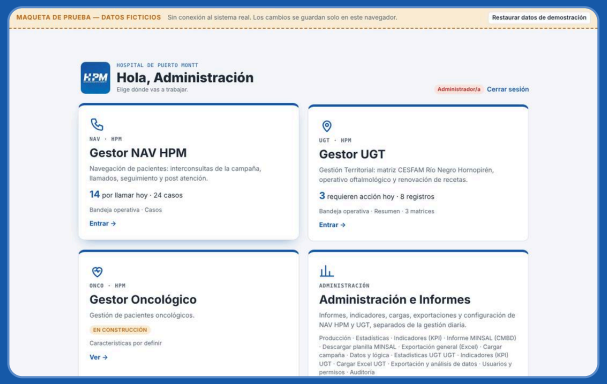
Las pantallas corresponden a la maqueta del gestor y muestran solo datos ficticios.

HPM **Hospital de Puerto Montt**

GUÍA VISUAL

Conozcamos el Gestor NAV HPM

Una guía visual para conocer el sistema y comprender nuestro flujo de trabajo.



Pantallas reales de la maqueta · datos ficticios

Navegadores NAV HPM · Gestión Territorial UGT

QUÉ ES

¿Para qué sirve el gestor?

Ordena el acompañamiento de pacientes y deja registro de cada acción.

Organizar los casos
Cada caso es una interconsulta. La bandeja dice cuáles atender hoy.

Registrar gestiones
Cada acción queda con quién la hizo, fecha y hora.

Consultar antecedentes
La ficha reúne los datos disponibles y su fuente.

Mantener el seguimiento
Calcula cuándo volver a llamar y la siguiente acción.

Cómo se relacionan las pantallas

Bandeja operativa — a quién llamar hoy

↓

Caso — antecedentes y trayectoria · Ficha del paciente

↓

Registro de gestión — resultado y estado

↓

Bitácora — quién, qué y cuándo · vuelve a la bandeja

Dos módulos separados

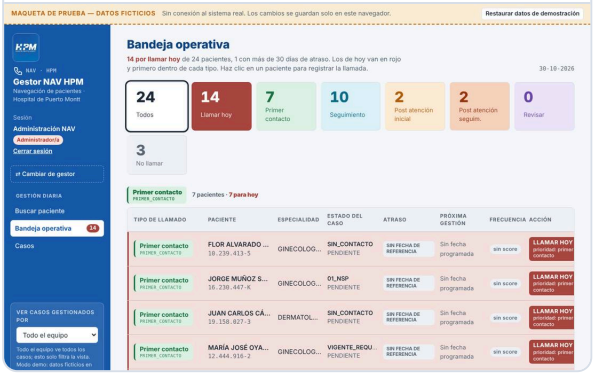
Gestor NAV HPM
Navegadores: contacto con pacientes de la campaña, seguimiento y post atención.

Gestor UGT
Gestión territorial: matriz principal, operativo oftalmológico y renovación de recetas.

GESTOR NAV HPM

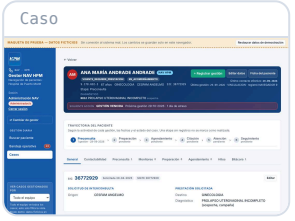
El trabajo de los navegadores

Bandeja operativa

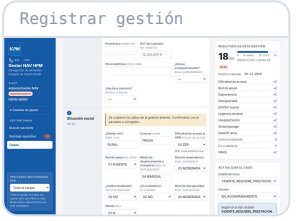


1. **Revisar la bandeja**
   Quién corresponde llamar hoy, agrupado por tipo de llamado.
2. **Seleccionar un caso**
   Desde la bandeja o buscando por RUT o nombre en Casos.
3. **Revisar los antecedentes**
   Cabecera, trayectoria, pestañas y Ficha del paciente.
4. **Realizar la gestión**
   Actividad y script según lo conversado.
5. **Registrar el resultado**
   Y actualizar el estado cuando corresponda.
6. **Ver el siguiente paso**
   La bitácora y la siguiente acción del caso.

Caso



Registrar gestión



El orden es orientativo: la bandeja y el caso indican qué corresponde en cada momento.

GESTOR UGT

El trabajo en UGT

Bandeja operativa UGT



1. **Entrar al Gestor UGT**
   Desde Inicio. La bandeja muestra lo que requiere gestión hoy.
2. **Elegir la matriz**
   Todas juntas o una sola; las alertas marcan revisiones vencidas o datos faltantes.
3. **Revisar el registro**
   Paciente, solicitud, prioridad y siguiente acción.
4. **Registrar la gestión**
   Lo realizado, observación, estado y próxima revisión.

Matriz principal
Hoja MATRIZ RNH: exámenes, controles, informes y apoyo al usuario.

Operativo oftalmológico
Columnas propias del operativo y equipo OFTA; único con estado ENVIADO.

Renovación de recetas
Medicamento y gestora territorial; las pendientes aparecen como alerta.

UGT no tiene plazos automáticos: la próxima revisión la fija quien registra. NAV HPM y UGT tienen estados e historiales propios.